Croix –Rouge Sénégalaise
Comité National
Boulevard Franklin Roosevelt Dakar
Bp : 299
Téléphone 33 823 39 92
crsnational@orange.sn

* * * * * * * * *

FASCICULE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Département de la Formation
Service Formation Recyclage & Examens

Octobre 2012

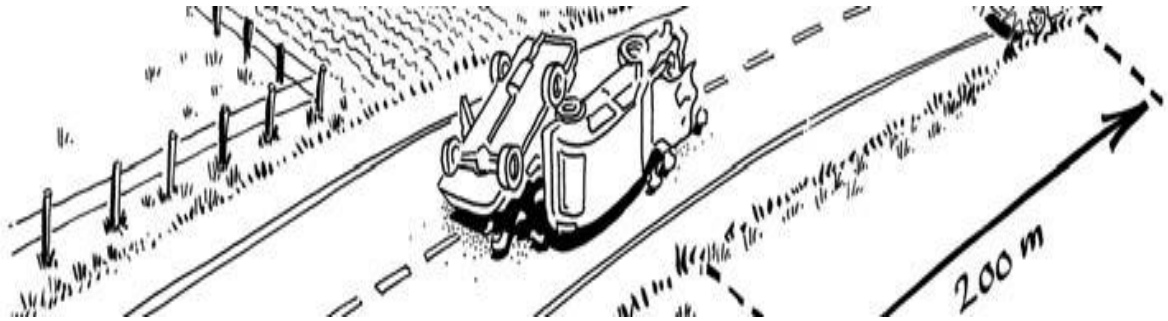
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Justification

- La vie de toute personne peut , un jour ou l'autre, être menacée par un accident ou une maladie brutale.
- Dans notre pays , les secours et les soins sont organisés;

il existe des structures publiques ou privées adaptées à ces détresses , chacune ayant un rôle précis

- (SAMU, Sapeurs -pompiers, Police, Gendarmerie , Hôpitaux, Cliniques, Ambulanciers, Professions de santé)
- Toute personne pouvant être témoin d'une situation de détresse doit :
  - Protéger au mieux en attendant l'arrivée des secours;
  - Alerter ces structures;
  - Pratiquer les gestes simples pouvant conserver une vie.
- Chacun d'entre nous peut donc être le Premier maillon de la chaîne de secours et de soins.
- La chaîne de secours et de soins ne peut fonctionner sans son premier maillon, le témoin qui donne « L'Alerte »



ETRE SECOURISTE:

C'est d'abord **Savoir porter secours** efficacement et **Éviter l'aggravation** de l'état d'un accidenté

C'est un rôle **primordial**, **limité** et **temporaire**

En présence d'un blessé, le secouriste garde son sang-froid; il fait à temps les Gestes d'urgence pour remettre aux médecins un blessé vivant, non aggravé; il apporte à ce blessé le secours psychologique dont

il a tant besoin, il empêche un comportement néfaste de témoins incompétents **Un rôle limité et temporaire**

- Le secouriste intervient grâce à ses connaissances et à sa technique ;il ne dispose souvent que d'un matériel improvisé
- Il donne l'ALERTE
- Son action s'arrête quand le spécialiste intervient:

Être secouriste est aussi avoir l'esprit de prévention

- Le secouriste est averti des risques d'accidents , d'intoxications, de maladies, en vue de leur prévention
- Le SECOURISME est donc à la fois une TECHNIQUE et un ETAT d'ESPRIT.

Une TECHNIQUE

- Le secouriste se forme par des exercices pratiques répétés.
- Il entretient régulièrement ses connaissances
- il répète les Gestes d' Urgence pour les Posséder presque par Réflexe...

Un État d' Esprit

- **Le secouriste a le désir de servir;**
- **d'être utile;**
- **d'aider son prochain**
- **Le secourisme fait partie de la formation de l'homme**

PRINCIPES D'ACTION

Après une Analyse très rapide de la Situation

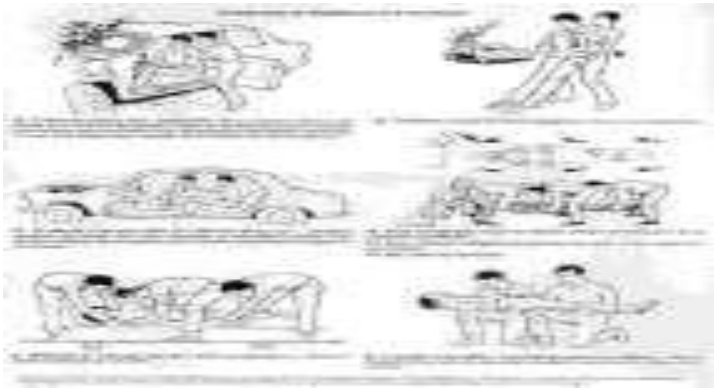
- ❑ PROTEGER

LES DEGAGEMENTS D'URGENCE

- Un blessé ne doit jamais être déplacé car cela peut être dangereux et risque d'aggraver son état. Cependant il est des situations exceptionnelles dans lesquelles il doit être déplacé:

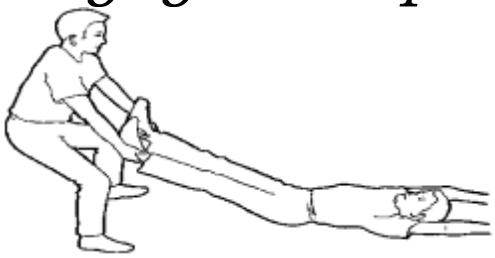
- Victime dans un véhicule commençant à prendre feu.
- Victime allongée sur une route à grande circulation.
- Victime que l'on voit dans une pièce enfumée ou en feu.

Victime menacée par un éboulement ou encore effondrement, coulée de boue , montée des eaux , allongée sur un passage à niveau...



Trois techniques sont utilisées et dépendent des situations:

- *Dégagement d'un véhicule,*
- *Dégagement par les poignets*
- *Dégagement par les chevilles*





EVITER L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE L'ACCIDENTE

- **BALISER OU DEGAGER**
- **FAIRE ALERTER**

❑ **SECOURIR**

- ***BILAN DE L'EXAMEN DE LA VICTIME***

-EXAMEN

❑ **GESTES D'URGENCES**

LA PROTECTION ET L'ALERTE

En présence d'un accident, le sauveteur sur place est :

*Le **premier maillon** de la **chaîne de secours** et de soins d'urgence.*

*Son rôle est **primordial**, il doit :*

- *Protéger du Suraccident et,*
- *Alerter les secours.*

Qui : le Sauveteur- les Témoins – la victime

Comment: cela dépend de la situation et des circonstances

ARBRE DE DECISION POUR LA PROTECTION

- Existe-t-il un danger pour le sauveteur ?
  - Le danger est-il contrôlable ?
    - OUI, supprimer le danger pour le sauveteur
    - NON, baliser la zone
- Existe-t-il un danger pour la victime ?
  - Le danger est-il contrôlable ?
    - OUI, supprimer le danger pour la victime
    - NON, dégagement d'urgence possible ?

      *OUI, supprimer le danger pour la victime

      *NON, baliser la zone et faire alerter
- Existe-t-il un danger pour les témoins ?
  - Le danger est-il contrôlable ?
    - OUI, supprimer le danger pour les témoins
    - NON, baliser la zone

PROTEGER

C'est reconnaître, sans s'exposer soi -même, les risques persistants qui menacent la victime de l'accident et les autres personnes exposées

1- Identifier les risques persistants

(écrasement, électrisation, incendie, explosion etc)

2- Peut-on les supprimer de façon permanente et sans risque?

- Si oui, le faire ou le faire faire (---)

3- Si non,peut-on isoler le risque de façon permanente et sans risque?

- Si oui, le faire ou le faire faire (---)

4-Si non, peut- on soustraire la victime sans risque?

- Si oui, le faire ou le faire faire (---)

Si non ,interdire l'accès à la zone dangereuse et faire alerter les secours spécialisés

ALERTER

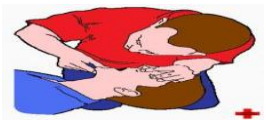
L'EXAMEN ET LA SURVEILLANCE
LE BILAN

C'est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée.

- La victime saigne-t-elle abondamment?
- La victime s'étouffe-t-elle?
- La victime répond-elle aux questions, se plaint-elle?
- La victime, si elle ne répond pas, respire- t-elle?

- L'examen préalable de la victime conditionne les gestes de secours et la précision du message d'Alerte.
- Il est effectué en quelques secondes.





PROTEGER

Saigne – t –elle ? — oui → ARRETER L'HEMORRAGIE

NON

Répond aux questions simples
Obéit aux ordres simples
Réagit aux stimulations

Est-elle consciente ? — oui → COMPLETER LE BILAN

NON

Desserrer ceinture, cravate, et col
Basculer prudemment la tête en arrière
Ouvrir la bouche et la nettoyer

ASSURER LA LIBERATION DES VOIES AERIENNES

-Plaintes de la victime (douleurs, malaises…)
-Examen de la victime

Bruits
Souffle
Mouvements du thorax/abdomen

Respire-t-elle ? — oui → POSITION LATERALE DE SECURITE

NON

PRATIQUER 4 INSUFFLATIONS

5 à 6 S

Le pouls carotidien est –t-il perçu ? — → EFFECTUER LA VENTILATION ARTIFICIELLE

NON

EFFECTUER LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE

SURVEILLER LA VICTIME

Les positions d’attente et de Sécurité





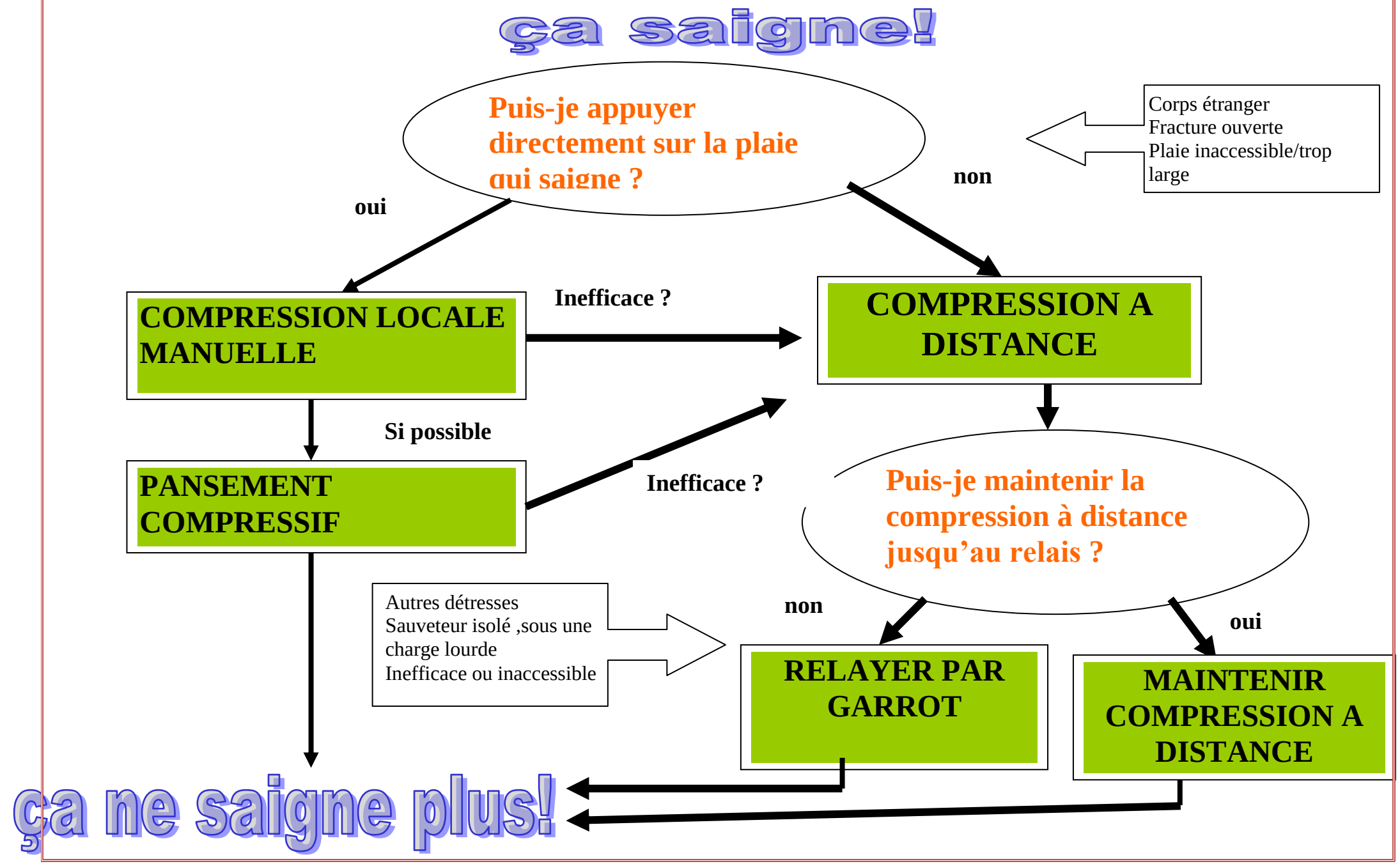











ça saigne!
Puis-je appuyer directement sur la plaie qui saigne ?
non
Corps étranger
Fracture ouverte
Plaie inaccessible/trop large
oui
COMPRESSION LOCALE MANUELLE
Inefficace ?
COMPRESSION A DISTANCE
Si possible
PANSEMENT COMPRESSIF
Inefficace ?
Puis-je maintenir la compression à distance jusqu'au relais ?
Autres détresses
Sauveteur isolé ,sous une charge lourde
Inefficace ou inaccessible
non
oui
RELAYER PAR GARROT
MAINTENIR COMPRESSION A DISTANCE
ça ne saigne plus!

Les saignements sont systématiquement recherchés chez un blessé. L'action du Secouriste doit être rapide pour éviter une détresse circulatoire qui peut entraîner la mort.

COMPRESSION MANUELLE

Pour arrêter un saignement :

- Comprimer immédiatement la plaie avec la paume de la main
- Allonger la victime
- Maintenir la compression
- Faire alerter les secours par un témoin
- Faire couvrir
- Surveiller la victime

PANSEMENT COMPRESSIF









Le secouriste remplace la compression manuelle par un pansement compressif constitué d'un linge propre plié et maintenu par un lien large.

- ❖ Commencer par une compression manuelle
- ❖ Sans lâcher la compression
- ❖ Mettre en place un pansement compressif
- ❖ Alerter les secours, couvrir, surveiller la victime

Devant un saignement associé à une fracture ouverte, la présence d'un corps étranger ou à une plaie plus large que la main, la compression manuelle et le pansement compressif ne doivent pas être effectués.

Le secouriste réalise un **POINT DE COMPRESSION**
Sur la victime allongée, le secouriste comprime le vaisseau situé entre le cœur et le saignement contre un plan dur osseux.
Cette compression à distance est maintenue jusqu'au relais par les secours.

La victime est couverte.

Membre supérieur
Appuyer avec le pouce derrière la clavicule en direction des pieds.
Cou
Appuyer avec le pouce à la base du cou contre les vertèbres, les autres doigts prenant appui sur la nuque
Membre inférieur
Appuyer dans le pli de l'aine avec le poing, bras tendu.

Garrot

La mise en place d'un garrot est réalisée lorsque le point de compression est impossible à maintenir (sauveteur isolé, plusieurs victimes à secourir, membre sous une charge lourde)
Utiliser un lien large et le serrer fortement ; *ne jamais desserrer le garrot* ; note l'heure de la pose
La victime est allongé et couverte.
Le garrot peut également être posé au bras
Pour tout saignement important, surélever les jambes.

Elles resteront impérativement dans cette position jusqu 'au relais par les secours

LES HEMORRAGIES INTERNES

Le sang s'écoule à l'intérieur du corps, on ne le voit pas couler .il s'agit de cas graves, difficiles, souvent trompeurs dont le secouriste doit être particulièrement averti : seule l'intervention chirurgicale peut arrêter l'hémorragie.

Une hémorragie interne peut être provoquée :

- Par un coup contre la poitrine, le ventre ou le dos : une simple contusion de l'abdomen (piéton renversé, chute sur une marche d'escalier) peut suffire à provoquer l'éclatement du foie, de la rate ou d'un rein

ou bien l'éclatement de l'estomac, de l'intestin ou de la vessie.

- Par une blessure par arme blanche, balle de revolver, éclat d'une explosion ; la plaie est étroite mais profonde ; le sang coule surtout à l'intérieur ;
- Parfois spontanément : rupture d'une grossesse de siège anormal (grossesse extra-utérine).

Une hémorragie interne se reconnaît uniquement par l'aspect du blessé : il est pâle, il a froid, il peut perdre progressivement conscience. Il est difficile de palper le pouls ; si on parvient à le prendre, on le trouve très faible, très rapide.

En cas d'hémorragie interne, il faut éviter l'aggravation du collapsus : le blessé atteint d'hémorragie interne est allongé sur le dos horizontalement, membres inférieurs surélevés s'il est conscient, en PLS s'il est inconscient, enveloppé dans une couverture, évacué de toute urgence vers l'hôpital, car il risque de mourir rapidement .on ne doit jamais donner « de stimulant » ; ni café ni alcool, ni injection » pour soutenir le cœur ». en effet , augmenter le débit circulatoire, c'est accentuer l'hémorragie.

LES HEMORRAGIES EXTERIORISEES

SAIGNEMENT DE NEZ

Le sang s'écoule par un orifice naturel.
Le saignement de nez ou épistaxis survient spontanément ou à la suite d'un coup sur le nez ;

- *On peut l'arrêter en comprimant avec le doigt, la narine qui saigne, pendant 10 minutes, laisser le sujet assis, tête en avant, ne jamais l'allonger sur le dos.*

VOMISSEMENTS DE SANG ET CRACHEMENTS DE SANG

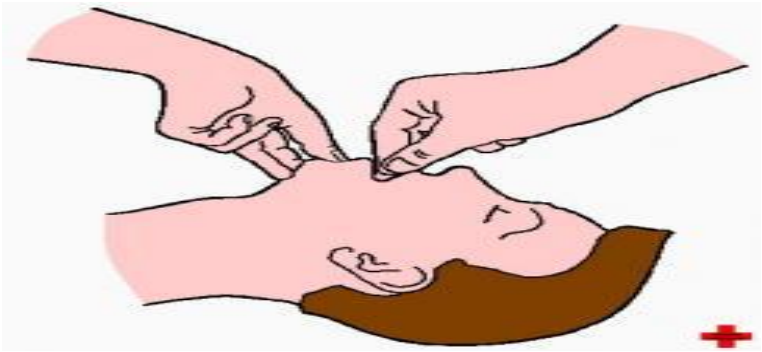
Un sujet peut être pris brusquement soit de vomissements sanglants (hématémèse), soit de crachements de sang survenant en toussant (hémoptysie).
Dans les deux cas, le malade doit conserver la plus stricte immobilité en position latérale de sécurité, ou demi assis s'il ne supporte pas la position allongée.
Les vomissements et les crachats

Tout écoulement anormal de sang (hémorragies anale ou rectale, urinaire, génitale) doit être signalé au médecin, de même que des selles noires (hémorragie intestinale).
L'urine est un liquide normalement clair et jaune ; l'apparition d'une coloration foncée ou rouge doit faire craindre une hémorragie

LES DETRESSES RESPIRATOIRES

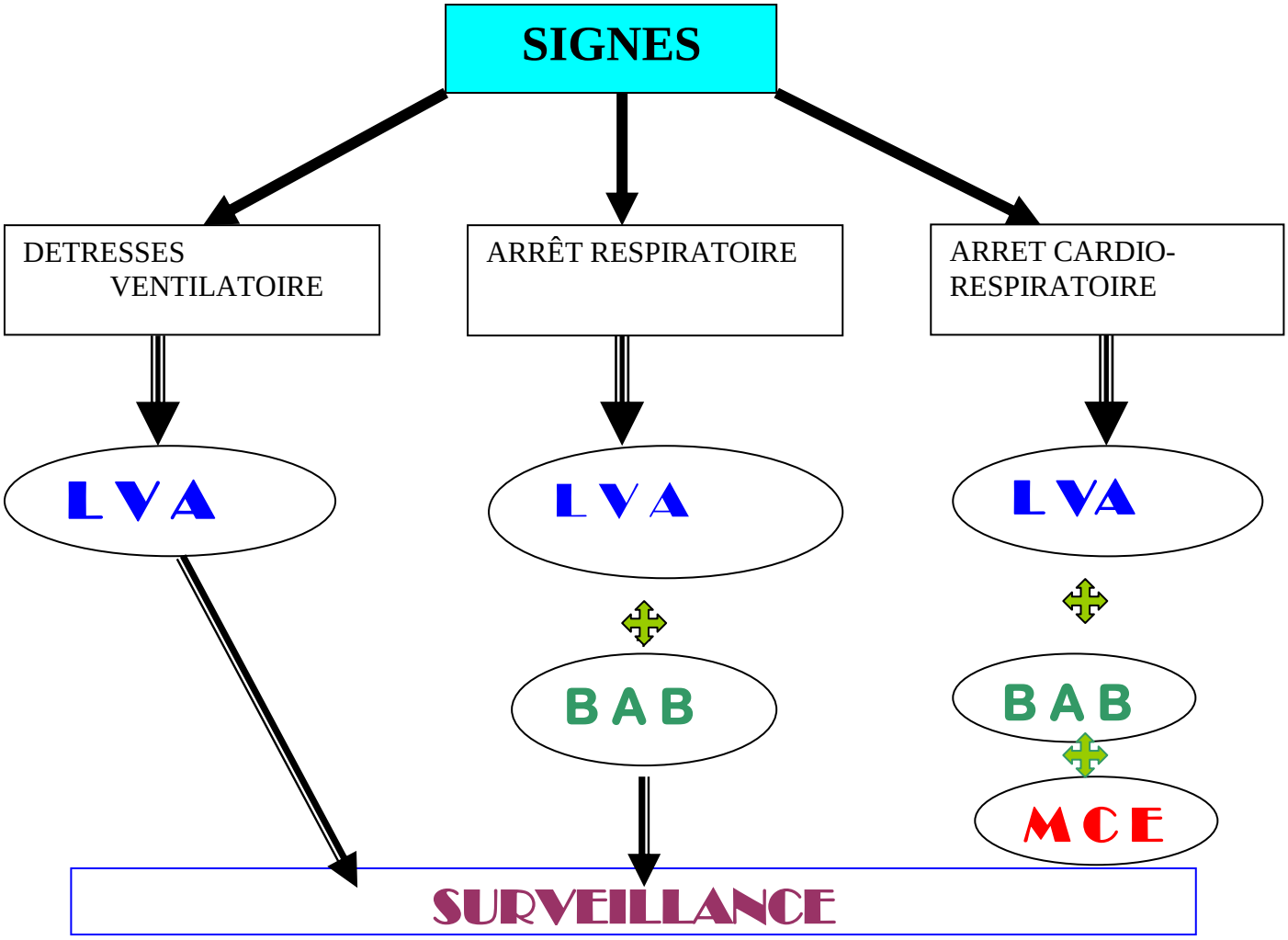
1- RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE

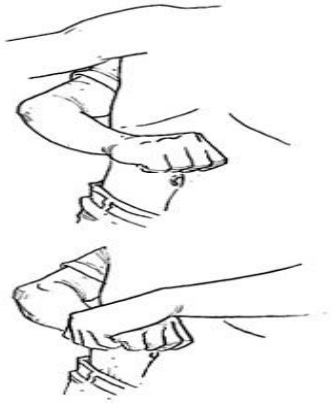
- L'APPAREIL RESPIRATOIRE
- LA RESPIRATION
- L'OXYGENE
- L'APPAREIL CIRCULAOIRE
- RÔLE DU SANG





IV- C A


SIGNES
DETRESSES VENTILATOIRE
ARRÊT RESPIRATOIRE
ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE
LVA
LVA
LVA
BAB
BAB
MCE
SURVEILLANCE





VENTILATION ARTIFICIELLE

DEVANT UNE VICTIME SANS CONNAISSANCE

- Assurer la libération des voies aériennes,
- Vérifier l'absence de ventilation,
- Pratiquer 4 insufflations par la méthode Bouche à bouche,
- Vérifier la présence du pouls carotidien,

Poursuivre le bouche à bouche jusqu'au relais par les secours

Le bouche à bouche

- D'une main maintenir le menton de la victime vers le haut et en avant,
- de l'autre main pincer le nez,
- Appliquer votre bouche sur celle de la victime
- Insuffler progressivement l'air contenu dans vos poumons (12 à 20 fois par minute) ;
- Se relever pour permettre l'expiration de la victime en regardant sa cage thoracique s'abaisser.

Le bouche à nez :

1. **Fermer la bouche de la victime ;**
2. **Plaquer vos lèvres autour de son nez ;**
3. **Procéder ensuite comme pour le bouche à bouche .**

Le bouche à bouche et nez :

- Chez le nourrisson, insuffler directement l'air dans la bouche et le nez.
- Le volume insufflé est moins important que chez l'adulte, mais la fréquence d'insufflation plus élevée.

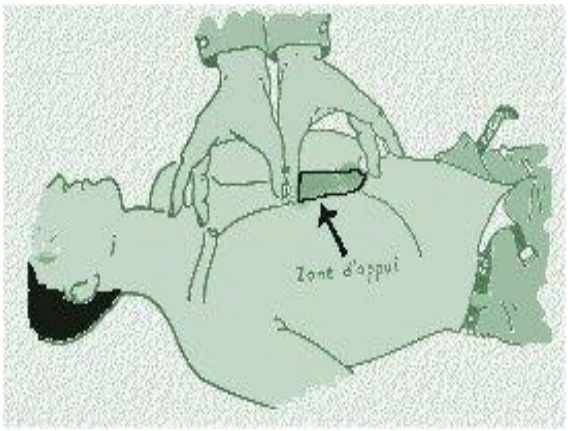
L'ARRÊT CARDIAQUE

Devant une victime inconsciente, il faut :

- Assurer la liberté des voies aériennes,
- Vérifier l'absence de ventilation,
- Pratiquer quatre insufflations
- Vérifier l'absence du pouls carotidien
- Faire alerter les secours
- Pratiquer le Massage Cardiaque Externe associé à la ventilation artificielle.

LE MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE





- Allonger la victime à plat dos sur un plan dur
- Ecarter à angle droit un bras de la victime, se placer à genoux à cheval sur ce bras, un genou au contact de l'aisselle

- Placer le talon d'une main sur le haut de la moitié inférieure du sternum, les doigts décollés des côtes et placer l'autre main sur la première ;
- Effectuer une poussée verticale bras tendus, puis relâcher sans décoller les mains
- Réaliser successivement 15 compressions thoraciques et 2 insufflations ;

Contrôler le pouls carotidien toutes les 2 minutes environ,

- **Il est absent** : continuer compressions et insufflations
- **Il est présent** : Arrêter les compressions thoraciques et continuer les insufflations.

Cette technique peut – être réalisée à 2 secouristes :

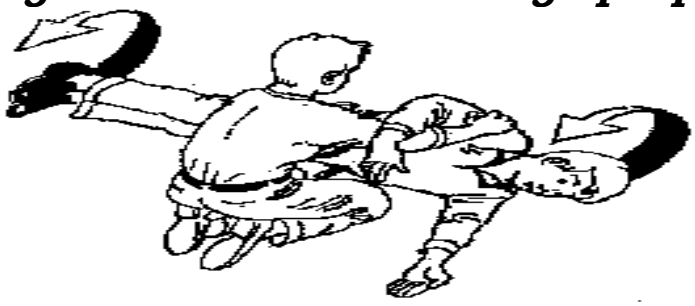
(L'alternance est alors :
5 compressions thoraciques et 1 insufflation)

L'INCONSCIENCE

Chez une victime inconsciente et qui respire, la chute de la langue et l'inhalation des vomissements entraînent une obstruction des voies respiratoires. Il faut donc, après avoir basculé la tête en arrière, mettre la victime en **POSITION LATERALE DE SECURITE**.

- **Desserrer le col, la cravate et la ceinture**
- **Basculer prudemment la tête en arrière en tirant le menton vers le haut.**
- **Vérifier que la victime respire correctement**

Si on entend des bruits, nettoyer la bouche avec un ou deux doigts recouverts d'un linge propre.



Pour mettre la victime sur le côté :

- Ecarter son bras du côté du retournement au – delà de la perpendiculaire de l'axe du corps,
- saisir l'épaule et la hanche de la victime du côté opposé,
- Faire tourner lentement le corps vers soi en bloc et sans torsion,
- Fléchir la jambe du dessus sur la cuisse au sol pour bloquer le pied au mollet, le coude touche terre pour assurer la stabilité du corps,
- Placer prudemment la tête en arrière, bouche ouverte dirigée vers le sol,
- Surveiller la victime et la couvrir,
- Alerter ou faire alerter les secours

La Fonction locomotrice

Le squelette constitue la charpente du corps; c'est l'ensemble des os reliés entre eux par des articulations

Il existe trois types d'os:

Long: fémur, qui se casse comme une branche



Plat: os du crâne , qui se casse comme une vitre

Court:vertèbre, qui s'écrase comme une noix

Le crâne
La colonne vertébrale ou rachis
La cage thoracique
Le bassin
Les membres supérieurs
Les membres inférieurs

Les os peuvent s'accroître jusqu'à vingt cinq ans.

Le squelette n'a pas uniquement un rôle de soutien; l'os est une matière vivante; c'est dans la moelle rouge de l'os que se forment les globules rouges.

Un os fracturé se répare spontanément lorsque les fragments osseux sont en contact l'un de l'autre; la membrane qui développe l'os (périoste) fabrique de l'os neuf(cal)

Une articulation comporte

Les extrémités des deux os recouvertes de cartilage: l'une formant une poulie creuse l'autre poulie pleine.

Une capsule fibreuse et des ligaments qui réunissent les os ,fermant ainsi la cavité articulaire.

Les muscles: rouges , blancs ou lisses.

Traumatisme du membre supérieur

Devant une personne qui présente, à la suite d'une chute ou d'un choc au niveau du membre supérieur:

- Une douleur vive
- Un gonflement
- Une difficulté ou l'impossibilité de bouger , on peut craindre une fracture, une luxation ou une entorse

Il faut:

- Éviter les mouvements ou les manipulations
- Immobiliser le membre atteint à l'aide d'une écharpe ou d'un vêtement;
- Alerter les secours;
- Réconforter la victime;
- Surveiller.



Devant une personne qui présente, à la suite d'une chute ou d'un choc à la tête, un des signes suivants:

- Une plaie du cuir chevelu;
- Un enfoncement du crâne;
- Un saignement par le nez ou l'oreille;
- Un comportement anormal (agitation,prostration);
- Des vomissements ou des maux de tête

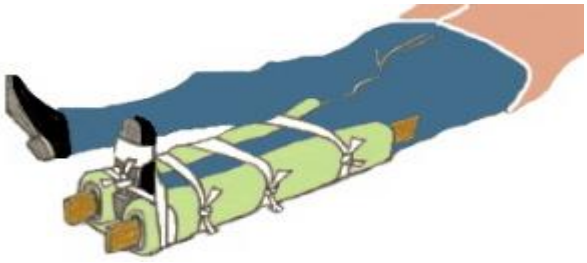
Il faut:

- *Allonger la victime*
- *Faire alerter les secours*
- *Surveiller la conscience en lui parlant régulièrement;*
- *Mettre en position latérale de sécurité en cas de saignement de nez, de l'oreille ou de vomissements*

Devant une personne qui présente une douleur dans le dos ou qui ne peut plus bouger à la suite d'une chute ou d'un choc, on doit craindre une atteinte de la colonne vertébrale.

Il faut:

- Éviter toute manipulation;
- Demander à la victime de rester immobile;
- Lui maintenir la tête avec les deux mains;
- Faire alerter les secours;
- Surveiller, réconforter;
- Faire couvrir.



Les atteintes traumatiques

Les atteintes traumatiques concernent

Elle concerne :

les brûlures, les plaies, morsures et piqûres d'animaux.
Les brûlures sont des atteintes de la peau provoquées par la chaleur

I Les brulures

A Causes

- Le feu
- Les produits chimiques
- L'électricité
- Le soleil, le frottement

B Signes

Les brûlures peuvent être plus ou moins graves: on distingue:

- Une plaque rouge peu étendue
- Une peau avec boutons contenant du liquide
- La peau et la chair atteintes

La gravité d'une brûlure dépend de son étendue plus que de sa profondeur, de sa localisation (face, organes génitaux), du produit, de l'âge(les touts petits et les vieillards)

C *CAT Conduite à tenir*

- Arroser à l'eau courante sans pression
- Retirer sans attendre bague, montre et autres parures avant que la partie brûlée ne commence à enfler.
- recouvrir entièrement au moyen d'un linge propre la partie brûlée
- Emballer, étiqueter, installer et évacuer devant une brûlure grave.

1 Si les vêtements et les cheveux d'une personne sont en feu

- Éteindre les flammes en les étouffant avec de l'eau ou avec une couverture ou en roulant la victime à même le sol
- Prendre les dispositions requises pour que la victime reçoive le plus rapidement possible les premiers soins médicaux

2 Devant un brûlé par produits chimiques:

- *Arroser à grande eau*
- *Arracher les habits de la victime*
- *Référer immédiatement*

D Prévention:

- Vider les cendres chaudes dans une fosse
- Conseiller aux femmes de ne pas porter de vêtement en tissu synthétique à proximité du feu
- Interdire l'accès de la cuisine aux enfants.

II. Les plaies

A. Définition:

Il y a plaie lorsque la peau est coupée, déchirée, éraflée, arrachée ou fortement contuse.

B. Cause:

- Objets tranchants (couteau, lame, machette, hache)
- Armes à feu
- Objets pointus ou rugueux

C. Signes:

- ***1- Plaie Simple*:**

  - ✓ Coupure de la peau
  - ✓ Piqûre superficielle
  - ✓ Éraflure (qui ne saigne pas)

- ***2- Plaie grave*:**
  - **Saignement**
  - **Profondeur**
  - **Étendue**
  - **Localisation**
  - **Présence de corps étrangers**
  - **Plaie du thorax ou de l'abdomen**

D. CAT - Conduite à tenir

3. devant une plaie simple:

- ✓ Se laver les mains à l'eau savonneuse
- ✓ Mettre des gants à usage unique si possible
- ✓ Nettoyer la plaie du centre vers l'extérieur
- ✓ Protéger la plaie

4. devant une plaie grave:

- ✓ Installer la victime dans une position adaptée à son état et à ses lésions
- ✓ Protéger la plaie à l'aide d'un linge propre
- ✓ Couvrir la victime
- ✓ L'amener à la structure de santé la plus proche

III. Morsures et piqûres d'animaux

- *Les morsures et piqûres d'animaux peuvent être dangereux et provoquer des douleurs, l'infection, l'état de choc et même la mort:*

A. Les Causes:

- ✓ Abeilles, scorpion
- ✓ Chien, chat,serpent

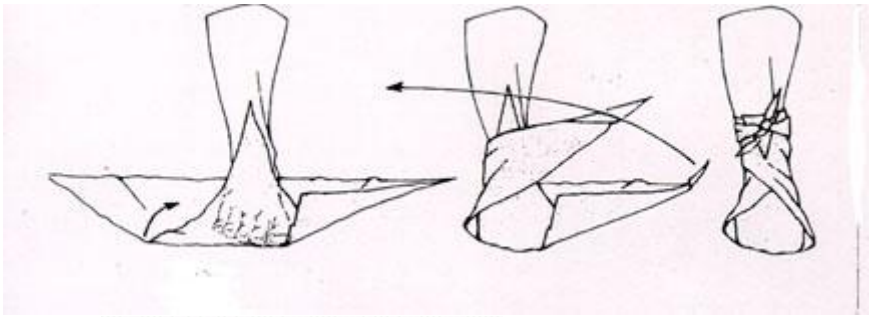
B. les Signes:

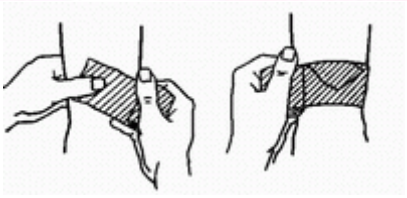
- Douleur, rougeur, tumeur au niveau de la partie atteinte
- Trace de morsure (chien, serpent)
- Présence de dard (abeilles)

CAT Conduite à tenir

- *Injecter le sérum antivenimeux contre les morsures de serpent ou antirabique contre les morsures de chien, chat etc.*
- *Aider la victime à garder son calme*
- *Nettoyer soigneusement la plaie avec du savon*
- *Rincer la blessure à grande eau*
- *Couvrir la blessure d'un pansement propre*
- *Identifier l'insecte ou l'animal et évacuer la victime vers la structure de santé la plus proche*







BANDAGES & EMBALLAGES

Un bandage sert à maintenir ou à protéger un pansement ou une parie du corps blessé.

Un bandage peut se faire avec des bandes, mais le secouriste démuni de bande n'est pas embarrassé pour improviser un bandage: il confectionne une fronde ou il utilise un triangle de tissu.

I Les BANDES

A Il existe plusieurs sortes de bandes:

Toile, gaze, crêpe, élastique(Velpeau), des pansements individuels

La largeur de la bande diffère suivant l'endroit où le bandage est appliqué:

5cm pour le doigt, 7cm pour la main, la tête, les segments de membre etc., 10cm pour la cuisse, l'épaule, le tronc.

B REGLES DE POSE/

- **Le Globe (partie roulée) toujours en l'air**
- **On commence tout bandage par 2 circulaires**
- **Le chef légèrement mis en biais, l'angle est rabattu entre le premier tour et le second: ainsi la bande ne glisse pas.**
- **Décalé la bande d'un trière de sa largeur**
- **Tout bandage est terminé par 2 circulaires, fixés par un nœud plat ou une épingle de sûreté**

Si la bande est trop courte, on termine par une bande de même dimension

C TECHNIQUE DE BANDAGE

Le Spirale, le Renversé, le Spica, la Tortue, le monocle, le Bandage de la cheville, le Chausson, le Croisé des tempes, Capeline etc…..

II Les Emballages

D COMPOSITION D'UN EMBALLAGE

- *Les emballages triangulaires sont improvisés à l'aide de triangles de toile, ou de carrés de toile repliés en triangle permettant de faire rapidement l'emballage provisoire d'une plaie grave*
- Les triangles comportent un sommet ou angle droit, opposé à la base ou grand côté et deux chefs, la partie centrale s'appelle le plein.
-

E REGLES DE POSE:

Le sommet vers la racine du membre

F Pour les parties du corps

Front, nuque, épaule, hanche, coude
Main, pied, jambe, thorax, abdomen etc.

Relevages, Brancardages,Portages

- *Le transfert d'une victime lors de relevages, brancardages ou portages, implique des manutentions manuelles.*
- *Pour tout équipier, cette activité physique comporte un risque d'accident corporel, notamment vertébral.*
- *Des manœuvres effectuées « en force »dans des positions et avec des gestes inappropriés, font subir des contraintes énormes aux risques inter- vertébraux.*
- Ces risques sont accrus en raison:
  - Des caractéristiques de la charge (blessé ou malade, « fragile »),
  - De la configuration des lieux (terrain accidenté, sol instable, obstacle naturel ou architectural);
  - De conditions ergonomiques défavorables (matériel non performant telles que des sangles, manque d'utilisation d'aides techniques simples)

L'atteinte de la colonne vertébrale se manifeste immédiatement par une incapacité fonctionnelle. Les suites peuvent être relativement bénignes (»tour de rein ») ou plus graves (lumbago, sciatalgie, hernie discale).

La manifestation brutale de l'accident lombaire, chez un équipier en cours de manutention peut contrarier brusquement la manœuvre et affecter la sécurité du blessé, du malade,comme celle des autres équipiers.

Elles sont basées sur :

- La stabilité des positions
- La fermeté des prises
- La sécurité des mouvements
- Le travail avec les muscles des membres inférieurs

Le rapprochement de l'axe du porteur et de la charge



METHODES DE RAMASSAGE

- PONT SIMPLE
- PONT AMELIORE
- PONT NEERLANDAIS
- PONT NERLANDAIS AMELIORER
- CUILLER à 3(cuiller à 3 +1(à4ou 4+1)
- Le brancardage est un travail qui nécessite une certaine résistance physique.
- Il se pratique à 2, 4 ou 5 équipes, sous la responsabilité d'un chef.
  - À 2, le chef se place derrière, entre les hampes du brancard
  - À 4, le chef est à l'arrière à l'extérieur de la hampe droite
  - À 5, le chef marche à droite, à côté du brancard, il ne participe au brancardage que pour les passages délicats.
- Les Mouvements du Brancard doivent être doux , synchronisés
- Le Brancard doit rester toujours horizontal.
- Les Brancardiers ne doivent pas marcher au pas.
- En règle général, le blessé est transporté la tête en avant sauf s'il est sous ventilation artificielle ou sous perfusion.

Commandements du brancardage

En position

Êtes – vous prêts?.....Prêt

Attention pour lever.....Levez

Attention pour avancer.....Avancez

Attention pour arrêter.....Arrêtez

Attention pour poser.....Posez

les opérations de manutention et de levage sont potentiellement dangereuses, aussi bien pour l'Homme, pour l'environnement, que pour les installations :

- Risque d'écrasement

- Risque de chute d'objet

En conséquence :

- ***Analysons et préparons le travail à effectuer***
- ***Choisissons le matériel ou l'engin adapté à la situation***
- ***Utilisons-le dans les règles de sécurité qui en découlent***

E.P.I

ECRASEMENT, BRÛLURE THERMIQUE OU CHIMIQUE, SALISSURES, COUPURE, ASPHYXIE, FATIGUE, SURDITE, INTOXICATION, CHUTE, GLISSADE, ATTEINTE AUX YEUX

Pour chaque type de travail, il existe des risques associés contre lesquels nous devons - nous prémunir. Si la protection collective est reconnue insuffisante, ou des événements imprévus sont possibles, nous devons porter des équipements de protection individuelle (E.P.I.) adaptés aux risques.

FEUX ET EXTINCTEURS

L'incendie

- Les incendies font chaque année de nombreuses victimes
- Surtout des enfants, et entrainent des destructions considérables (immeubles, usines, forêts), la plupart sont la conséquence d'une imprévision ou d'une imprudence

Ce que doit savoir Le Secouriste

- Le secouriste qui n'est pas sapeur- pompier ne confond pas son rôle avec celui des spécialistes de la lutte contre l'incendie.

- **<u>Mais il doit connaitre</u>**:
  - Le mécanisme de l'incendie et ses causes (Triangle du Feu)
  - La Prévention de l'incendie
  - Les gestes simples qui peuvent empêcher l'éclosion d'1 incendie.
  - La façon d'alerter les Sapeurs- pompiers
  - La CÂT en présence d'1 personne, dont les vêtements ont pris feu.
  - Le dégagement d'une victime d'un local enfumé.

L'utilisation des extincteurs d'incendie

- Un incendie est une combustion désordonnés et incontrôlable qui se produit quand sont réunies trois conditions
  - Un combustible (solide-liquide ou gazeux)
  - Un comburant, le plus souvent l'oxygène de l'air
  - Une élévation localisée de température (chaleur, flamme ,étincelle, échauffement anormalement élevé d'un appareil de chauffage ou de ventilation, échauffement ou court- circuit dans les fils, les câbles ou les appareils électriques, frottement, réaction chimique)

Le Triangle du Feu(Schéma)

- Les liquides qui émettent des vapeurs sont inflammables
- Le feu se développe s'il y a renouvellement d'air ou si la température du foyer augmente: des produits volatifs et très combustibles apparaissent et propagent l'incendie.

- La construction et l'aménagement des bâtiments et des locaux
- Le stockage rationnel de toutes matières inflammables
- La mise à la terre des appareils et des machines pour éviter les effets de l'électricité statique et des courants dits de « fuite »
- La généralisation de l'application effective de l'interdiction de fumer dans les rares locaux ou cela peut parfois être autorisé, disposer des cendriers métalliques clos
- Toutes ces dispositions doivent être prises conformément à des règles strictes, fixées par des textes officiels et contrôlés par des organismes spécialisés ou agrées

Les Extincteurs

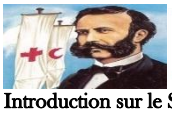
Classe A	**Classe B**	**Classe C**
Feux Secs (solides)	**Feux gras (liquides)**	**Feux de gaz**
Tissus, bois,paille,papier, caoutchouc	***Essence, peintures, hydrocarbures*** ***Huiles grasses, acétone, alcool***	***Propane, butane, gaz de ville***
Produites extincteurs appropriés		
Eau pulvérisée	**Poudre Co2 halogénés**	**Poudre**
Poudre polyvalente		





Thèmes

Connaissance du Mouvement international de la Croix –Rouge



Introduction sur le Secourisme

Conduite à Tenir devant un Accidenté



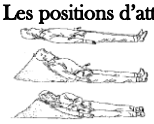
Principes généraux

Protéger
Alerter
Secourir

Les dégagements d'urgence



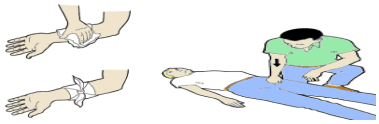
Les positions d'attente et de Sécurité



Examen et Bilan d'une victime

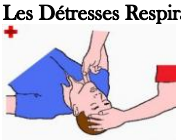


Les Détresses Circulatoires



Les hémorragies
Les points de Compression

Les Détresses Respiratoires

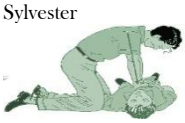


Etouffement
Techniques de LVA
HEIMLICH

Ventilation artificielle



Bouche à bouche
Nielsen
Sylvester



Massage Cardiaque Externe



Les Traumatismes des Os et Articulations



Fractures – Entorses et Luxations

Les Immobilisations

Les Echarpes

La sécurité d'Entreprise :

Prévention des risques liés à l'activité du travail
Risques chimiques
Les règles de base : management sécurité
Connaissance et manipulation des extincteurs



La gestion du risque en sécurité

Le soin psychologique

Le rôle du secouriste en milieu du travail

Travail en équipe

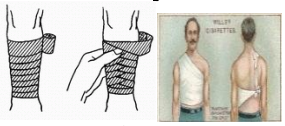
La sécurité routière : Les accidents routiers



Les normes de sécurité

Les accidents domestiques

Les atteintes de la peau



Les plaies / Les Brûlures
Les Piqûres et morsures

Les Bandages

Les Emballages
Les Frondes

Les Principes de Manutention et de Relevage



Techniques de Ramassage
Le Brancardage
Les Transports improvisés

Les Malaises



Les différentes crises :

Epileptiques
Cardiaques
Vasculaires

Les troubles de la vigilance

Les maladies tropicales
Le Paludisme- les Intoxications





Hygiène et Assainissement etc

Evaluation Finale moyenne de : 12/20

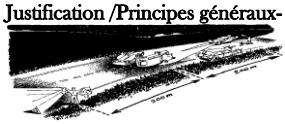
****

Programme d'Initiation

(04 heures à 06 heures de cours théoriques et pratiques)



Justification /Principes généraux-



Protéger
Alerter
Les dégagements d'urgence



Les positions d'attente et de Sécurité



Examen et Bilan d'une victime



Les hémorragies



Les points de Compression



Etouffement





Techniques de LVA

HEIMLICH



Bouche à bouche

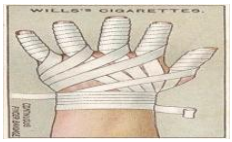


Nielsen Sylvester

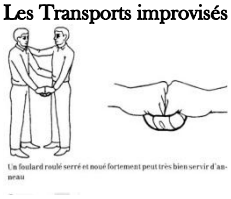


Massage Cardiaque Externe

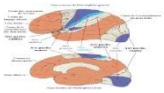
Le rôle du secouriste en milieu du travail
Les Brûlures
Les Emballages



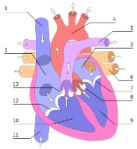
Les Transports improvisés



Les malaises :



Vasculaires



Cardiaques

Epileptiques



Service Formation Recyclage /examens

SND

Croix –Rouge Sénégalaise
Comité National
Boulevard Franklin Roosevelt Dakar
Bp : 299
Téléphone 33 823 39 92
crsnational@orange.sn

CROIX - ROUGE SENEGALAISE